

L'ICF — Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute

Percorsi nelle disabilità · Sessione 06 · 17 marzo 2026

Oggi entriamo nel cuore del modello con cui il lavoro sociale guarda alla disabilità: l'ICF. Non è solo uno strumento burocratico — è un cambio di mentalità radicale su cosa significa essere "in difficoltà". Prenditi il tempo per capirlo bene: ti servirà per ogni progettazione che farai in carriera.

Perché esiste l'ICF — Il nuovo concetto di salute

Prima di capire l'ICF, bisogna capire **perché** è nato.

Per decenni la salute era definita in negativo: sei sano se non sei malato. L'OMS ha ribaltato questa visione. La **salute non è assenza di malattia — è uno stato di piena forma dell'intera persona, che include il livello fisico, psicologico, personale, familiare e sociale.** È anche legata all'ambiente: la salute non può essere separata dal contesto in cui la persona vive.

"La salute è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell'esistenza." — **OMS, Ottawa Charter for Health Promotion, 1986**

Questo **concetto positivo di salute è la radice da cui cresce l'ICF.**

Pensa a te stesso: un giorno ti alzi e tutto gira bene — sei in forma, hai buone relazioni, il contesto ti supporta. Un altro giorno non funziona nulla — forse hai un fastidio fisico, forse sei di umore nero, forse il luogo dove sei è caotico. L'ICF cattura esattamente questa complessità.

Cos'è l'ICF

ICF sta per **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute**. È uno strumento dell'OMS elaborato nel 2001 che appartiene alla stessa famiglia di classificazioni internazionali dell'ICD-10.

Ma attenzione: è il suo **opposto complementare**.

	ICD-10	ICF
Cosa fa	Classifica le malattie e le loro cause	Classifica il funzionamento della persona
Domanda chiave	"Qual è il problema biologico?"	"Come funziona questa persona nel suo contesto?"
Logica	Lineare, causale	Sistemica, multidimensionale
Guarda	Ciò che manca (deficit)	Ciò che è possibile (risorse)
Ottica	Negativa (patologia)	Positiva (funzionamento)

L'ICF non sostituisce l'ICD — lo completa. La diagnosi dice *cosa* ha una persona. L'ICF dice *come* quella persona vive, funziona e partecipa alla vita sociale.

Esistono tre versioni: - **ICF classico** — per adulti - **ICF-CY (Children and Youth)** — per bambini e giovani 0-18 anni, con maggiore attenzione all'ambiente e allo sviluppo evolutivo - **ICF versione breve** — classificazione semplificata, meno livelli di dettaglio

Il cambio di paradigma: dal modello medico al modello biopsicosociale

Questo è il cuore della lezione.

Il **modello medico** (individuale-riabilitativo) ragiona così: - C'è una causa biologica (malattia, danno organico) - Questa causa produce un deficit - Il deficit va trattato/curato/riabilitato - **La persona è "il problema"**

Il **modello biopsicosociale dell'ICF** ragiona diversamente: - La persona ha caratteristiche interne (biologiche e psicologiche) - Queste caratteristiche interagiscono con l'ambiente esterno - Da questa interazione nasce il funzionamento — oppure la disabilità - **La disabilità non è nella persona — è nella relazione tra persona e contesto**

"La disabilità è definita dalle relazioni che intercorrono tra le condizioni della persona e i fattori contestuali."

Questo cambia tutto il modo di lavorare. Come operatore sociale, non ti chiedi "qual è il problema di questa persona?" — **ti chiedi "quali condizioni permettono a questa persona di funzionare meglio e partecipare alla vita?"**

Il prof sottolinea che questa non è filosofia: è una questione pratica concreta. **Se lavori con un ragazzo che a casa va benissimo ma in struttura è in difficoltà, la domanda ICF è: cosa c'è nell'ambiente di casa che facilita? E cosa c'è nella struttura che ostacola?**

Fin qui ci siamo? Bene, ora viene la parte strutturale.

La struttura dell'ICF — Come è organizzato

L'ICF è un librone molto denso. Non devi saperlo a memoria — devi capirne la struttura. È organizzato **a grappolo**, con una gerarchia precisa:

ICF

- ├ Parte 1: Funzionamento e Disabilità

- ├ Funzioni corporee (8 domini)

- ├ Strutture corporee (8 domini)

- └ Attività e Partecipazione (9 domini)

- └ Parte 2: Fattori Contestuali

└─ Fattori ambientali (5 domini)

└─ Fattori personali (non classificabili)

Funzioni corporee

Le **funzioni corporee** sono le funzioni fisiologiche dei sistemi del corpo, incluse quelle psicologiche. Descrivono cosa *fa* ogni organo e sistema.

I verbi sono la chiave: mangiare, assaggiare, camminare, vedere, ricordare... descrivono le funzioni delle strutture anatomiche corrispondenti.

8 domini delle funzioni corporee: 1. Funzioni mentali (coscienza, orientamento, memoria, attenzione, intellettive...) 2. Funzioni sensoriali e dolore 3. Funzioni della voce e dell'eloquio 4. Funzioni cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio 5. Funzioni dell'apparato digerente, metabolico ed endocrino 6. Funzioni genitourinarie e riproduttive 7. Funzioni neuromuscoloscheletriche e correlate al movimento 8. Funzioni della cute e strutture correlate

Strutture corporee

Le **strutture corporee** sono le parti anatomiche del corpo: organi, arti, e le loro componenti. Sono parallele alle funzioni — stessi 8 domini, ma guardano l'anatomia invece del funzionamento fisiologico.

Esempio: il codice **s2204** indica il cristallino (s2 = occhio/orecchio, s220 = struttura del bulbo oculare, 04 = cristallino).

Chi valuta funzioni e strutture corporee? Tipicamente il medico specialista o l'operatore sanitario. **Non è il lavoro specifico dell'operatore sociale — ma è importante conoscerle perché fanno parte del quadro complessivo.**

Attività e Partecipazione

Questa è la componente che ci riguarda più da vicino come operatori sociali.

- **Attività** = l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo

- **Partecipazione** = il coinvolgimento in una situazione di vita

9 domini dell'attività e partecipazione: 1. Apprendimento e applicazione delle conoscenze (guardare, ascoltare, leggere...) 2. Compiti e richieste generali (intraprendere, gestire, eseguire) 3. Comunicazione (ricevere, produrre, conversare...) 4. Mobilità (camminare, trasportare, spostarsi...) 5. Cura della propria persona (lavarsi, vestirsi, mangiare...) 6. Vita domestica (procurarsi beni, compiti casalinghi, prendersi cura) 7. Interazioni e relazioni interpersonali (semplici, complesse, formali, intime) 8. Aree di vita principali (istruzione, lavoro, vita economica) 9. Vita sociale, civile e di comunità (ricreazione, diritti, religione)

Questi 9 domini sono la **griglia di osservazione** dell'operatore sociale. Pensa a un PEI: ogni obiettivo può essere ancorato a uno di questi domini.

Capacità vs Performance — Una distinzione fondamentale

Nella valutazione dell'attività e della partecipazione, l'ICF introduce due concetti che sembrano simili ma non lo sono.

Capacità = ciò che una persona *può* fare in un ambiente standard, neutro, senza adattamenti specifici. È una caratteristica intrinseca della persona, indipendente dall'ambiente.

Performance = ciò che una persona *fa effettivamente* nel suo ambiente attuale (reale, con i supporti in atto). Dipende dall'interazione con l'ambiente.

Esempio dalla lezione: una persona che cucina ottimamente nel suo foyer adattato (piano regolabile, utensili in posti precisi, routines note) ha alta **capacità** in quell'ambiente. Ma se la porti in una cucina standard qualsiasi, la sua **performance** può essere molto più bassa.

Perché conta questa differenza? Perché ci dice *dove* lavorare. Se voglio inserire questa persona lavorativamente in una cucina professionale, devo capire cosa, nel contesto standard, crea difficoltà e come intervenire su quello — non solo applaudire la performance nel contesto protetto.

Il prof porta l'esempio delle scarpe con gli allacci: se l'obiettivo è imparare ad allacciarsi le scarpe, la mamma che continua a comprare scarpe con le strisce sta agendo come **barriera** — non come facilitatore. Non perché la mamma sia "sbagliata", ma perché quella specifica azione ostacola l'obiettivo educativo definito.

Parte 2 — Fattori Contestuali

Fattori ambientali

I **fattori ambientali** sono le influenze esterne che possono avere impatto positivo (facilitatori) o negativo (barriere) sul funzionamento della persona.

5 domini dei fattori ambientali: 1. Prodotti e tecnologia (ausili, strumenti, tecnologie assistive) 2. Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall'uomo (geografia, clima, luce, suono...) 3. Relazioni e sostegno sociale (famiglia, amici, colleghi, operatori...) 4. Atteggiamenti (delle persone intorno, della società in generale) 5. Servizi, sistemi e politiche (sanitari, educativi, economici, legali...)

Attenzione al dominio degli **atteggiamenti**: non è solo l'ambiente fisico che può essere barriera o facilitatore. L'atteggiamento di chi sta intorno — la convinzione che una persona "non ce la farà mai" — è una barriera concreta. Al contrario, credere nel potenziale di una persona è un facilitatore reale.

Esempio: tre educatori che danno indicazioni diverse simultaneamente a un bambino che sta imparando ad allacciarsi le scarpe sono una **barriera** — non per cattiveria, ma perché quella situazione specifica ostacola l'apprendimento.

Il prof su questo è molto diretto: **noi siamo parte dell'ambiente**. Il nostro modo di stare, di credere, di agire condiziona il funzionamento delle persone con cui lavoriamo. Questo è la responsabilità professionale citata negli obiettivi.

Fattori personali

I **fattori personali** sono le caratteristiche interne dell'individuo: sesso, età, forma fisica, stile di vita, abitudini, educazione, background sociale, esperienze di vita, capacità di adattamento, stile caratteriale...

Questi fattori **non sono classificati nell'ICF** — non per dimenticanza, ma perché è impossibile standardizzare la varietà infinita del vissuto umano. Il background di chi è cresciuto in un campo profughi non è confrontabile con quello di chi è cresciuto in un ambiente privilegiato: entrambi sono reali e influenzano il funzionamento, ma non si possono codificare universalmente.

Barriere e Facilitatori — Il cuore dell'azione educativa

Facilitatore = fattore ambientale che migliora il funzionamento in una specifica attività. La sua presenza riduce la disabilità — può evitare che una menomazione diventi una restrizione della partecipazione.

Esempi: ascensore in stazione, educatore convinto del potenziale dell'utente, ambiente adattato, rete di supporto familiare, ausili tecnologici.

Barriera = fattore ambientale che limita il funzionamento e crea o amplifica la disabilità. Ostacola l'attività e la partecipazione.

Le barriere possono essere: - **Fisiche/architettoniche** — scale, assenza di rampe, spazi non accessibili - **Sociali** — atteggiamenti stigmatizzanti, esclusione, pregiudizi - **Economiche** — mancanza di risorse per partecipare ad attività - **Ambientali** — rumore, luce eccessiva, spazio caotico - **Relazionali** — atteggiamenti degli educatori, della famiglia, dei pari

L'operatore sociale fa la "caccia alle barriere": individua sistematicamente cosa ostacola il funzionamento e cosa lo supporta, per poi agire di conseguenza.

La Codifica — Come si usa l'ICF in pratica

L'ICF usa un **sistema alfanumerico** standardizzato a livello internazionale. Un codice compilato in Svizzera è leggibile anche in Germania o in Spagna.

Le lettere indicano la componente: - **b** (body) — Funzioni corporee - **s** (structure) — Strutture corporee - **d** (domain) — Attività e Partecipazione - **e** (environment) — Fattori ambientali

I numeri specificano il dominio in modo gerarchico progressivo. **Esempio:**
b167 = funzioni mentali del linguaggio; **b1670** = recepire il linguaggio; **b16700** = recepire il linguaggio verbale.

Il qualificatore viene scritto dopo il punto e indica la gravità: - Per funzioni/strutture: **0** (nessuna menomazione) → **4** (menomazione completa) - Per attività/partecipazione: primo qualificatore = performance, secondo = capacità - Per fattori ambientali: **+** = facilitatore, **.** = barriera (scala 0-4)

Dalla qualificazione emergono quattro tipi di situazioni: 1.

Menomazione — disfunzione a livello di funzione o struttura corporea 2.

Limitazione — difficoltà nell'esecuzione di un'attività specifica 3. **Restrizione** — problema nel coinvolgimento/partecipazione 4. **Barriera** — fattore contestuale ostacolante

Come operatori sociali, la nostra area di valutazione è attività, partecipazione e fattori contestuali. Le funzioni e strutture corporee sono terreno medico.

Implicazioni professionali — Cosa ce ne facciamo noi?

L'ICF ha applicazioni molto concrete nel lavoro quotidiano:

1. Griglia di osservazione sistematica I 9 domini di attività e partecipazione ci dicono esattamente dove guardare quando osserviamo una persona. Niente è lasciato al caso.

2. Costruzione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) Ogni obiettivo del PEI può essere ancorato a un dominio ICF specifico. Quasi tutti i PEI moderni si ispirano ormai al modello ICF.

3. Linguaggio condiviso Usare i termini ICF permette a medici, educatori, assistenti sociali e famiglie di comunicare in modo preciso e condiviso, anche tra paesi diversi.

4. Ricerca di barriere e facilitatori L'ICF ci dà gli strumenti per individuare sistematicamente cosa ostacola il funzionamento e cosa invece supporta la partecipazione.

5. Responsabilità professionale Noi siamo parte dell'ambiente. Il nostro atteggiamento, le nostre credenze, il nostro modo di agire *condiziona* il funzionamento delle persone con cui lavoriamo. Questa consapevolezza è il centro della responsabilità educativa.

Domande di orientamento allo studio

Cos'è l'ICF e in cosa si distingue dall'ICD? L'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) è uno strumento OMS del 2001 che classifica il funzionamento della persona nel suo contesto — si chiede "come funziona questa persona nella vita reale?". L'ICD invece classifica le malattie e le loro cause seguendo la logica eziologia → patologia → manifestazione clinica. L'ICF non sostituisce l'ICD: lo completa. La diagnosi dice cosa ha una persona; l'ICF dice come quella persona vive, funziona e partecipa alla vita sociale. Il cambio chiave è passare da una visione negativa (il deficit) a una positiva (il funzionamento).

Qual è la struttura dell'ICF? Quali sono le sue componenti principali?

L'ICF è organizzato in due parti. Parte 1 — Funzionamento e Disabilità: comprende le funzioni corporee (8 domini: mentale, sensoriale, voce, cardiovascolare, digestivo, genitourinario, neuro-muscolo-scheletrico, cute), le strutture corporee (8 domini paralleli, anatomici) e le attività e partecipazione (9 domini: apprendimento, compiti generali, comunicazione, mobilità, cura di sé, vita domestica, relazioni

interpersonali, aree di vita principali, vita sociale e civile). Parte 2 — Fattori Contestuali: include i fattori ambientali (5 domini: prodotti e tecnologia, ambiente naturale, relazioni e sostegno, atteggiamenti, servizi e politiche) e i fattori personali (non classificabili per la varietà infinita del vissuto umano).

Cosa si intende per capacità e performance nell'ICF? Perché questa distinzione è rilevante per la pratica? La capacità descrive ciò che una persona può fare in un ambiente standard e neutro, senza adattamenti specifici — è una caratteristica intrinseca della persona. La performance descrive ciò che la persona fa effettivamente nel suo ambiente attuale, con i supporti in atto. La differenza è determinata dall'ambiente. Un esempio: una persona che cucina bene nel suo foyer adattato ha alta capacità in quel contesto, ma la sua performance in una cucina standard non adattata può essere molto più bassa. Questa distinzione è importante perché indica dove intervenire: se voglio inserire una persona in un nuovo contesto, devo capire cosa nell'ambiente standard crea difficoltà e come modificarlo — non solo osservare la performance nel contesto protetto.

Cosa sono i fattori ambientali nell'ICF? Qual è la responsabilità professionale dell'operatore sociale? I fattori ambientali sono le influenze esterne che possono avere impatto positivo (facilitatori) o negativo (barriere) sul funzionamento della persona. I 5 domini includono prodotti e tecnologia, ambiente naturale, relazioni e sostegno sociale, atteggiamenti delle persone e della società, servizi/sistemi/politiche. L'attenzione agli atteggiamenti è cruciale: la convinzione che una persona "non ce la farà mai" è una barriera concreta, come la credenza nel suo potenziale è un facilitatore reale. La responsabilità professionale fondamentale dell'ICF è che noi operatori siamo parte dell'ambiente: il nostro modo di stare, di credere, di agire condiziona il funzionamento delle persone con cui lavoriamo.

Quali sono le implicazioni pratiche dell'ICF nel lavoro sociale quotidiano? L'ICF ha cinque applicazioni concrete: (1) griglia di osservazione sistematica — i 9 domini di attività e partecipazione dicono esattamente dove guardare quando si osserva una persona; (2) costruzione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) — ogni obiettivo può essere ancorato a un dominio ICF specifico; (3) linguaggio condiviso tra medici, educatori, assistenti sociali e famiglie, anche tra paesi diversi grazie al sistema alfanumerico internazionale; (4) ricerca sistematica

di barriere e facilitatori per agire sul contesto; (5) sviluppo della consapevolezza della propria responsabilità educativa come operatori che sono parte dell'ambiente.

Come funziona il sistema di codifica ICF? L'ICF usa un sistema alfanumerico standardizzato. Le lettere indicano la componente: b (body) per funzioni corporee, s (structure) per strutture corporee, d (domain) per attività e partecipazione, e (environment) per fattori ambientali. I numeri specificano il dominio in modo gerarchico progressivo (es. b167 = funzioni mentali del linguaggio; b1670 = recepire il linguaggio; b16700 = recepire il linguaggio verbale). Il qualificatore numerico dopo il punto indica la gravità: da 0 (nessuna menomazione) a 4 (menomazione completa) per funzioni e strutture; per i fattori ambientali, + indica un facilitatore e . una barriera (scala 0–4).

Concetti chiave

Termine	Significato
ICF	Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute — OMS, 2001
ICF-CY	Versione per bambini e giovani (0-18 anni)
Cambio di paradigma	Passaggio dal modello medico-individuale al modello biopsicosociale
Modello biopsicosociale	Considera la persona nelle sue tre dimensioni (biologica, psichica, sociale) in interazione con l'ambiente
Funzionamento	Espressione positiva dell'insieme: funzioni corporee + attività e partecipazione
Disabilità	Termine ombrello per menomazioni, limitazioni e restrizioni — nasce dall'interazione tra persona e fattori contestuali
Menomazione	Disfunzione a livello di funzione o struttura corporea

Termine	Significato
Limitazione	Difficoltà nell'esecuzione di un'attività
Restrizione	Problema nel coinvolgimento/partecipazione
Capacità	Cosa una persona può fare in un ambiente standard/neutro
Performance	Cosa una persona fa effettivamente nel suo ambiente attuale
Facilitatore	Fattore ambientale che migliora il funzionamento e riduce la disabilità
Barriera	Fattore ambientale che limita il funzionamento e crea/amplifica la disabilità
Qualificatore	Codice numerico che valuta la gravità di menomazioni, limitazioni, restrizioni e barriere/facilitatori
PEI	Piano Educativo Individualizzato — strumento di progettazione ispirato all'ICF

Collegamenti

Lezioni precedenti collegate: - Sessione 04-05: modello individuale vs modello sociale (la "scala dell'accessibilità") — l'ICF è il modello sociale per eccellenza, che traduce in strumento operativo quel ragionamento - ICD-10 e ICDH: classificazioni che descrivono malattie e le loro conseguenze — l'ICF le completa spostando il focus dal deficit al funzionamento

Temi aperti / da approfondire: - Uso pratico della Checklist ICF e della Scheda Profilo di Funzionamento ICF-CY - Zona prossimale di sviluppo (Vygotsky) — collegamento con la valutazione capacità/performance - PPH (Processus de Production du Handicap) — altro modello biopsicosociale complementare all'ICF - Costruzione del PEI: come si usano concretamente i domini ICF nella progettazione

Riferimenti bibliografici: - Ianes D. (2004), *La diagnosi funzionale secondo l'ICF*, Erickson - OMS (2001), *Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)*, Erickson - Franchini R., *Disabilità, cura educativa e progetto di vita*, Erickson - OMS, *ICF Checklist*, settembre 2003 - Ianes D., Cramerotti S., Scapin C. (2019), *Profilo di funzionamento su base ICF-CY e PEI*, Erickson